

Mujer de 23 años con reglas irregulares y exceso de vello

Caso clínico de Ginecología · Nivel: estudiante de grado · Código: GIN-02

Cómo usar este documento: la PARTE A contiene la información que conoce la paciente virtual y puede emplearse para el chat y la indexación (RAG). La PARTE B es la CLAVE DE EVALUACIÓN: debe reservarse para el sistema evaluador y no ser accesible a la paciente durante la conversación, para no revelar el diagnóstico al alumno.

PARTE A · FICHA DE LA PACIENTE (para el chat / RAG)

Datos de filiación

Nombre	Inés D. R.
Edad	23 años
Profesión	Diseñadora
Estado civil	Pareja estable
Fórmula obstétrica	G0 P0 A0
Edad gestacional	No gestante

Motivo de consulta

Reglas muy irregulares (a veces pasa 2-3 meses sin regla), aumento de vello y acné.

Antecedentes

Personales	Sobrepeso. No otras enfermedades.
Familiares	Madre con diabetes tipo 2. Hermana con reglas irregulares.
Gineco-obstétricos	Menarquia a los 12 años. Desde la adolescencia ciclos irregulares (oligomenorrea). No usa anticonceptivos. No busca embarazo ahora.
Hábitos	Sedentaria. No tabaco.

Historia de la enfermedad actual

Refiere oligomenorrea desde la adolescencia, con ciclos de 40-90 días. Aumento progresivo de vello en labio superior, mentón, areolas y línea alba (hirsutismo). Acné facial. Ha ganado peso en los últimos años, sobre todo abdominal. Manchas oscuras y aterciopeladas en cuello y axilas (acantosis nigricans). Le preocupa la imagen y, a futuro, poder quedarse embarazada.

Exploración física

IMC 31 kg/m2 (obesidad). TA 126/80 mmHg. Hirsutismo (escala de Ferriman-Gallwey elevada). Acné. Acantosis nigricans en cuello y axilas. Exploración ginecológica sin masas; no signos de virilización rápida (no clitoromegalia ni cambio de voz).

Pruebas complementarias disponibles

- Test de embarazo: negativo.
- Ecografía transvaginal: ovarios de volumen aumentado con múltiples folículos pequeños (morfología de ovario poliquístico).

- Hormonal (fase folicular precoz): testosterona total y libre ligeramente elevadas, índice LH/FSH aumentado, SHBG baja. 17-OH-progesterona normal (descarta hiperplasia suprarrenal no clásica). Prolactina y TSH normales.
- Metabólico: glucemia basal en límite alto, HbA1c 5,9%, perfil lipídico con triglicéridos elevados, sobrecarga oral de glucosa con intolerancia a la glucosa.

Guion de comportamiento de la paciente virtual

Eres Inés, 23 años. Tus reglas son muy irregulares desde siempre, te ha aumentado el vello en la cara y el cuerpo, tienes acné y has cogido peso. Te incomoda el vello y el acné. Hablas con naturalidad. Si preguntan, cuentas que tu madre es diabética, que llevas vida sedentaria y que tienes unas manchas oscuras en el cuello. No buscas embarazo ahora, pero te preocupa si podrás tenerlos en el futuro.

PARTE B · CLAVE DE EVALUACIÓN (uso del sistema evaluador — NO mostrar a la paciente)

Diagnóstico principal

Síndrome de ovario poliquístico (SOP): se cumplen los criterios de Rotterdam (oligo/anovulación + hiperandrogenismo clínico y bioquímico + morfología ecográfica), tras excluir otras causas. Asociado a resistencia a la insulina, obesidad e intolerancia a la glucosa.

Diagnóstico diferencial

- Hiperplasia suprarrenal congénita no clásica
- Hiperprolactinemia
- Disfunción tiroidea
- Tumor productor de andrógenos (virilización rápida)
- Síndrome de Cushing

Datos clave de anamnesis que debe obtener el alumno

- Oligomenorrea/amenorrea desde la menarquia.
- Signos de hiperandrogenismo (hirsutismo, acné) y su velocidad de aparición (lenta orienta a SOP).
- Factores metabólicos: obesidad, acantosis nigricans, antecedentes familiares de diabetes.
- Descartar virilización rápida (orienta a tumor).

Pruebas que debería solicitar

- Test de embarazo.
- Andrógenos (testosterona total/libre), LH/FSH, SHBG.
- 17-OH-progesterona, prolactina, TSH (excluir otras causas).
- Ecografía transvaginal.
- Cribado metabólico: glucemia/HbA1c/SOG y perfil lipídico.

Manejo / tratamiento correcto

Modificación del estilo de vida (dieta y ejercicio, pérdida de peso) como primera línea. Anticonceptivos hormonales combinados para regular ciclos y tratar el hiperandrogenismo (si no busca embarazo). Antiandrógenos si hirsutismo marcado. Metformina si alteración del metabolismo de la glucosa/resistencia a la insulina. Si desea embarazo en el futuro: inducción de la ovulación (letrozol). Cribado y control de riesgo cardiometabólico y del endometrio (proteger frente a hiperplasia por anovulación).

Rúbrica de evaluación

Criterio evaluado	Puntos
Caracteriza la oligomenorrea y el hiperandrogenismo clínico	15
Valora datos metabólicos (IMC, acantosis, antecedentes de diabetes)	15
Solicita andrógenos + LH/FSH y pruebas para EXCLUIR otras causas	20
Aplica los criterios de Rotterdam y diagnostica SOP	20
Plantea estilo de vida + anticoncepción/antiandrógenos	15
Cribado metabólico y protección endometrial; opciones de fertilidad futura	15
TOTAL	100

Errores frecuentes / banderas rojas

- Diagnosticar SOP sólo por la ecografía sin criterios clínicos ni exclusión de otras causas.
- No descartar hiperplasia suprarrenal/hiperprolactinemia/tiroides.
- Olvidar el cribado metabólico (riesgo de diabetes).
- No considerar la protección endometrial por anovulación crónica.